Habilidades Cirúrgicas

Monitoria de TOCE

Revisão Flash · Sessão 12

Cirurgia Pediátrica

O essencial para a prova em uma página

Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º período · 2026.2

Elaborado por João Batista Fernandes Júnior · *Monitor de TOCE*

Revisado pela Profa. Fernanda Parreiras

Resumo elaborado pelo monitor para orientar o estudo. Não é referência bibliográfica *e pode conter erros: para estudo, prova e recursos, valem as aulas, as diretrizes e as fontes indicadas pela disciplina.*

Cirurgia pediátrica

Leitura de 5 minutos

Em uma frase

Vômito verde é obstrução até prova em contrário; estabilize (água, calor, glicose, sonda) antes do exame, escolha o exame que muda a conduta e saiba o que é emergência e o que é cirurgia programada.

1. **Vômito bilioso no RN:** pensar em má rotação com volvo; instável vai direto para a cirurgia.
2. **Piloro:** 2–8 semanas, jato não bilioso, alcalose; corrigir antes de operar.
3. **Dupla bolha:** atresia duodenal, síndrome de Down.
4. **Intussuscepção:** ultrassom (alvo) e redução por enema; peritonite = cirurgia.
5. **Mecônio após 48 h:** investigar obstrução (Hirschsprung: biópsia retal).
6. Fezes claras: bilirrubina direta e encaminhamento urgente; atresia confirmada, Kasai o quanto antes.
7. **Hérnia diafragmática:** sem máscara; intubar e sonda gástrica.
8. **Orquidopexia** até 12–18 meses; hérnia inguinal se opera, umbilical se observa.

Parede abdominal

	Gastrosquise	Onfalocele
Local	À direita	Central
Saco	Não	Sim
Anomalias	Atresia	Muitas

Pegadinha

Fimose fisiológica não se opera. Hipospádia não se circuncida. Parafimose é urgência.

Checklist antes da prova

- ☐ Separo vômito bilioso de não bilioso
- ☐ Sei o preparo do piloro
- ☐ Reconheço intussuscepção e sei reduzir
- ☐ Sei rastrear atresia de vias biliares
- ☐ Diferencio gastrosquise e onfalocele
- ☐ Sei a sala de parto da hérnia diafragmática
- ☐ Sei quando operar hérnia e testículo